

Parodontologie

Fascicule 12 · Examen parodontal, traitements non chirurgicaux et chirurgicaux

Étiologie principale : la **plaque dentaire**. Tout traitement parodontal doit débuter par une bonne maîtrise de l'élimination de la plaque. Gingivite = atteinte gencive SANS perte d'attache. Parodontite = perte d'attache + OS.

Examen parodontal

Plateau d'examen parodontal

Indications : Examen clinique + radiologique + diagnostic

Étape	Matériel
Set de consultation	Miroir · précelle · sonde droite
Sondage parodontal	Sonde parodontale millimétrée (mesure profondeur des poches)
Plaque	Révélateur de plaque
Radio	Film radio / capteur + angulateur
Examens complémentaires	Microscope optique · fiche clinique paro (papier ou numérique) · +/- porte-empreinte + alginate · +/- appareil photo

Diagnostic

Gingivite vs Parodontite

Indications : Différence clé : la perte d'attache

Étape	Matériel
Gingivite	Rougeur · œdème · hypertrophie gingivale · saignement spontané ou au brossage/sondage · PAS de perte d'attache
Parodontite	Atteinte des tissus superficiels ET profonds · PERTE D'ATTACHE · poches parodontales · destruction osseuse

Traitements non chirurgicaux — curetage / surfaçage

Plateau curetage / surfaçage

Indications : Élimination du tartre sous-gingival et du tissu inflammatoire — favorise le retour à un parodonte sain

Étape	Matériel
Anesthésie	Aiguille · carpule tiédie et désinfectée · porte-carpule · anesthésique de contact
Curetage / surfaçage	Curettes de Gracey (utilisation en traction · technique en aveugle · formes selon la dent à traiter et sa face)
Polissage	Brossette montée sur CA + pâte à polir
Antiseptiques	Matériel d'irrigation des poches (seringue + chlorhexidine par exemple)
Compresse	Compresse · aéropolisseur
US + insert	Détartreur ultrasonique + insert
Antibiotiques (si besoin)	Voie locale ou générale selon prescription

Traitements chirurgicaux

2 types : chirurgie d'assainissement (poches inaccessibles) OU chirurgie réparatrice (rétablir des conditions favorables).

Plateau chirurgie parodontale (lambeau d'assainissement, comblement osseux, ROG, greffe)

Indications : Protocole complet en 7 étapes

Étape	Matériel
Prévoir	Champ opératoire stérile · produit de désinfection exo/endo-buccale · sérum physiologique (nettoyer/rincer) · compresse · canule d'aspiration stérile
Anesthésie	Aiguille · carpule tiédie et désinfectée · porte-carpule · anesthésique de contact
Incision	Bistouri + lame
Décollement du lambeau	Décolleur
Curetage / surfaçage	Curettes de Gracey · US + insert
Comblement osseux (si besoin)	Matériau de comblement osseux
Sutures	Porte-aiguille · fil de sutures · ciseaux

Prescription pré/post-op : antibiothérapie · anti-inflammatoires · antalgiques · antiseptiques (bain de bouche) · brosses 6.5/100 puis 15/100 · poche de glace.

Maintenance parodontale

Visites de contrôle régulières · détartrage / polissage · rappel des règles d'hygiène. Pronostic gingivite = excellent si retour à une bonne hygiène. Pronostic parodontite = incertain, dépend de l'implication du patient.